

Pustka po AN — *najtrudniejsza faza terapii*

AN była tożsamością. Jej osłabienie odsłania pustkę. To nie regres — to etap. Praca: odkrywanie wartości, pasji, ról poza AN.

CZAS: miesiące pracy, środkowa i późna faza terapii

REALIZACJA: CBT-E faza 2-4, MANTRA identity module, ACT values

ŹRÓDŁO: Reid & Burr (2008, identity in AN); Schmidt & Treasure (2013, MANTRA); Hayes i in. (2012, ACT values); Tan, Hope & Stewart (2003, autonomia w AN)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **dlaczego AN staje się tożsamością** i co znaczy „pustka po AN”. Sekcja 02 — **siedem kroków odkrywania tożsamości**: wartości, pasje, role, marzenia. Sekcja 03 — **arkusz „kim jestem”** — wartości i konkretne kroki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

„Kim jestem bez AN?” — pytanie definiujące *najtrudniejszą* fazę terapii. AN nie jest tylko zaburzeniem — często staje się tożsamością: „jestem osobą, która kontroluje”, „jestem dyscyplinowany/-a”, „jestem wyjątkowy/-a”. Reid & Burr (2008): pacjenci opisują AN jako „najlepszego przyjaciela” i „jedyną tożsamość, jaką mają”. Konsekwencja: kiedy AN się osłabia (w terapii), pacjent doświadcza *pustki* — „kim ja jestem teraz?”. To nie jest regres ani niepowodzenie terapii — to *etap*, który trzeba przejść. Praca: odkrywanie wartości, pasji, ról, marzeń *poza AN*. ACT (Hayes i in., 2012) i MANTRA identity module: pacjent buduje *nową* tożsamość, opartą na wartościach, nie na kontroli ciała. Bez tej pracy — nawrót prawie pewny.

01 Dlaczego AN staje się tożsamością — i co to znaczy „pustka”

MECHANIZM

CO SIĘ DZIEJE PSYCHOLOGICZNIE

1 · AN daje „specjalność”	„Jestem osobą, która kontroluje”, „jestem dyscyplinowany/-a”, „wyjątkowy/-a”. W świecie, gdzie pacjent czuje się przeciętny/-a, AN daje poczucie odróżnienia. Reid & Burr (2008): AN jako „najlepszy przyjaciel”.
2 · AN organizuje czas i myślenie	Planowanie posiłków, śledzenie reguł, checking — wypełnia dni. Bez AN — pacjent nie wie, „co robić ze sobą”. To realna pustka czasu i uwagi.
3 · AN „chroni” przed innymi pytaniami	„Kim jestem?”, „czego chcę?”, „jakie mam relacje?” — te pytania są przerażające. AN je zastania: „nie myślę o tym, bo muszę kontrolować wagę”.
4 · Pustka po AN	Gdy AN się osłabia (terapia, refeeding), pacjent doświadcza <i>pustki</i> : „kim ja jestem teraz, jeśli nie kontroluję?”. To etap, nie regres. Praca: zbudować nową tożsamość.

Bez pracy nad tożsamością — nawrót prawie pewny. Pacjent „wyzdrowiały medycznie” (waga, jedzenie), ale bez nowej tożsamości — wraca do AN, bo bez niej czuje się pusty/-a. Tożsamość jest długoterminową profilaktyką nawrotu.

02 Siedem kroków odkrywania tożsamości

1. **Walidacja pustki** — „Pustka, którą czujesz, jest realna. AN była Twoją tożsamością. Jej osłabienie odsłania to, co AN zasłaniała. To etap, nie niepowodzenie”. Bez walidacji — pacjent ucieka z powrotem do AN.
2. **Wartości (ACT)** — „Co jest dla Ciebie ważne — niezależnie od ciała? Co chciałbyś/-łabyś, żeby było częścią Twojego życia?”. Pytania: relacje, kreatywność, służba innym, rozwój, autonomia, ciekawość, sprawiedliwość, duchowość.
3. **Wspomnienia „przed AN”** — „Co lubiłeś/-aś, kim byłeś/-aś przed AN? Co Cię cieszyło? Co Cię ekscytowało? Czego Ci dzisiaj brakuje z tamtych czasów?”. Pacjent pamięta część siebie sprzed AN.
4. **Role w życiu** — „Jakie role są Twoje (lub mogłyby być): córka/syn, przyjaciel/-ka, partner/-ka, pracownik/-ca, twórca/-czyni, uczeń/-nica, mentor/-ka?”. Każda rola — fragment tożsamości.
5. **Marzenia i cele** — „Gdyby AN zniknęła jutro, co byś chciał/-a zrobić w tym roku? W ciągu 5 lat? W życiu?”. Często pacjent odpowiada „nie wiem” — to też dane. Pracujemy z „nie wiem”.
6. **Małe, konkretne kroki** — wartości i marzenia bez kroków zostają teorią. „Co możesz zrobić w tym tygodniu, żeby przybliżyć się do tej wartości?”. Konkretne, mierzalne, niewielkie.
7. **Refleksja długoterminowa** — co 3–6 miesięcy pacjent wraca do tych pytań. Tożsamość ewoluuje — co było ważne rok temu, może już nie być. To proces, nie punkt docelowy.

03 **Kim jestem — arkusz wartości i kroków**

TRZY WARTOŚCI NAJWAŻNIEJSZE NIEZALEŻNIE OD CIAŁA

— relacje, kreatywność, służba, rozwój, autonomia, ciekawość, sprawiedliwość, duchowość, inne

CO LUBIŁEM/-AM PRZED AN — CO MNIE CIESZYŁO, EKSCYTOWAŁO

— bez oceny, czy „dobre”; ważne, że było moje

TRZY ROLE, KTÓRE SĄ MOJE (LUB CHCĘ, ŻEBY BYŁY)

— córka/syn, przyjaciel/-ka, partner/-ka, pracownik/-ca, twórca/-czyni, uczeń/-nica

GDYBY AN ZNIKNEŁA JUTRO, CO CHCIAŁBYM/-ŁABYM ZROBIĆ W CIĄGU ROKU

— marzenia, projekty, doświadczenia; „nie wiem” jest OK

MAŁY KONKRETNY KROK W TYM TYGODNIU W STRONĘ JEDNEJ Z MOICH WARTOŚCI

— np. rozmowa z X, czas na Y, spróbowanie Z

Klucz: praca nad tożsamością to *najtrudniejsza* faza terapii AN — i *najbardziej* zaniedbywana. Pacjenci „wyzdrowiali medycznie” (waga, jedzenie), ale bez nowej tożsamości — wracają do AN. Komunikat dla pacjenta: „nie chodzi o to, żebyś znalazł/-a „nową AN” — kolejną rzecz, która Cię definiuje. Chodzi o to, żebyś miał/-a wiele rzeczy, które razem tworzą Ciebie. Wartości, ludzi, role, marzenia. Pustka, którą teraz czujesz, jest miejscem na coś nowego — nie pozostanie pusta”. To długi proces — miesiące, lata.

⚠ **Pustka po AN — uwaga na komorbidność:** u niektórych pacjentów odsłonięcie tożsamości ujawnia ukryte zaburzenia: depresję, lęk, traumę, zaburzenia osobowości (BPD, ASPD). To nie regres — to często „cienie”, które AN zasłaniała. Wymaga rozszerzonej oceny i adaptacji planu terapii. Tożsamość budujemy w kontekście komorbidności, nie ignorując jej.